

TEMA 1.18 • PEDIATRÍA

Vacunas y Alimentación en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.2.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Vacunas y Alimentación en Pediatría

1. Vacunas — Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI)

Esquema PNI Chile (resumen por edad)

TABLA 1.18.1: EDAD VS VACUNAS	
EDAD	VACUNAS
RN (antes del alta)	BCG + Hepatitis B
2 meses	Pentavalente (DTPa-Hib-HB) + Polio inactivada (IPV) + Neumococo conjugada + Rotavirus
4 meses	Pentavalente + IPV + Neumococo + Rotavirus
6 meses	Pentavalente + IPV + Neumococo + Influenza
12 meses	SRP (Sarampión-Rubéola-Parotiditis) + Meningococo ACWY
18 meses	DTPa (refuerzo) + IPV (refuerzo) + SRP (2ª dosis)
4 años	DTPa + IPV (refuerzos)
8 años	Varicela
Adolescentes (14 años)	dTpa (Tdap, bajo titre) + VPH (según sexo)
Embarazada	dTpa (3er trimestre) + Influenza
Adulto mayor (≥ 65 años)	Influenza + Neumococo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Coqueluche: la vacuna a la embarazada en el 3er trimestre transfiere anticuerpos al RN, protegiéndolo antes de su primera dosis a los 2 meses (cuando más se mueren).

Contraindicaciones Generales

TABLA 1.18.2: CONTRAINDICACIÓN VS APLICA A	
CONTRAINDICACIÓN	APLICA A
Anafilaxia previa al componente de la vacuna	Todas
Enfermedad aguda febril grave	Todas (diferir)
Inmunodeficiencia grave (VIH avanzado, inmunosupresión)	Vacunas de virus vivos (SRP, varicela, rotavirus, BCG)
Embarazo	Vacunas de virus vivos
Alergia al huevo grave	Influenza, fiebre amarilla

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La fiebre leve o resfrió común NO contraindican la vacunación. Solo se difiere si la enfermedad aguda es grave (criterio clínico).

NOTA CLÍNICA

VIH asintomático / sin inmunosupresión grave NO contraindica la mayoría de las vacunas. Revisar caso a caso.

Reacciones Adversas

TABLA 1.18.3: TIPO VS EJEMPLOS	
TIPO	EJEMPLOS
Locales (frecuentes)	Dolor, eritema, induración en sitio de inyección
Sistémicas leves	Fiebre, irritabilidad, malestar general
Graves (raras)	Anafilaxia (primeros 15–30 min, observar post-vacuna)
BCG específico	Adenopatía local leve; absceso local si mala técnica
SRP	Exantema, artralgia leve a las 1–2 semanas (componente rubéola)

2. Alimentación en Pediatría

Lactancia Materna

Recomendación OMS/MINSAL: Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego complementada con sólidos hasta los 2 años.

- Contraindicaciones absolutas:
- VIH materno (riesgo de transmisión)
- Galactosemia en el lactante (no tolera la lactosa)
- Madre con tuberculosis activa no tratada
- Quimioterapia o radioterapia activa

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El VIH materno contraindica la lactancia materna en Chile (donde hay fórmula disponible). En países sin acceso a fórmula segura, los beneficios pueden superar el riesgo.

- NO contraindican la lactancia:
- Hepatitis B (con vacuna al RN)
- Hepatitis C (salvo pezones sangrantes)
- COVID-19 (con mascarilla)
- CMV en término (sí contraindica en prematuro < 32 sem)

Fórmulas Lácteas — PNAC (Plan Nacional de Alimentación Complementaria)

TABLA 1.18.4: DESTINATARIO VS FÓRMULA	
DESTINATARIO	FÓRMULA
RN término, 0–12 meses	Leche Purita Fortificada (fórmula estándar)
Prematuro < 32 semanas o < 1.500 g	Fórmula especial para prematuro
Niño 1–6 años	Leche Purita Cereal o similar
Embarazada / nodriza	Fórmula específica materna

Preparación Leche Purita (< 1 año): - Concentración: 7,5% (menor osmolaridad → protege riñón inmaduro) - Agregar azúcar o maltodextrina para aportar calorías sin aumentar osmolaridad

Introducción de Alimentos Sólidos

TABLA 1.18.5: EDAD VS ALIMENTO	
EDAD	ALIMENTO
6 meses	Inicio de papillas / purés (cereales sin gluten, frutas, verduras)
6-7 meses	Carnes, verduras cocidas
8-9 meses	Leguminosas, pasta, arroz
9-10 meses	Huevo (bien cocido)
12 meses	Leche de vaca entera
12 meses	Pescado (puede introducirse antes, vigilar alergias)
> 12 meses	Miel (riesgo de botulismo neonatal si < 12 meses)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Miel contraindicada < 1 año por riesgo de **botulismo del lactante** (*Clostridium botulinum* en esporas).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Leche de vaca entera contraindicada < 12 meses: exceso de carga renal de proteínas + déficit de hierro → anemia ferropénica.

Suplementos

TABLA 1.18.6: SUPLEMENTO VS INDICACIÓN	
SUPLEMENTO	INDICACIÓN
Hierro	Lactante sano: desde 4 meses hasta 1 año
Hierro	RN prematuro: desde 2 meses o al duplicar peso de nacimiento
Vitamina D	Todo lactante con LM exclusiva: desde el nacimiento hasta los 12 meses (400 UI/día)

Prevención de Obesidad

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses (factor protector)
- Introducción adecuada de sólidos sin azúcar añadida
- Evitar jugos y bebidas azucaradas
- Fomentar actividad física desde edades tempranas
- Pantallas: < 2 años sin pantallas (excepto videollamadas); 2-5 años máximo 1 hora/día supervisada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿A qué edad se recomienda iniciar la alimentación complementaria en un lactante con lactancia materna exclusiva sin problemas de crecimiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Vacunas y Alimentación en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses; continuar junto a alimentación complementaria hasta los 2 años
- Alimentación complementaria: inicio a los 6 meses; alimentos blandos, sin sal ni azúcar, sin miel antes de 1 año
- No leche de vaca entera antes de los 12 meses (proteínas inadecuadas + bajo hierro)
- Vitamina D: 400 UI/día desde RN, especialmente en lactantes con LM exclusiva sin exposición solar
- Hierro profiláctico: 2 mg/kg/día desde los 4 meses en prematuros; a los 6 meses para todos los lactantes
- Vacunas PANI Chile: BCG (RN), Hepatitis B (RN), Pentavalente 2-4-6m, Neumococo 2-4-12m, VPH niñas 4ºbásico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VACUNAS Y ALIMENTACIÓN EN PEDIATRÍA)

PREGUNTA 1

¿A qué edad se recomienda iniciar la alimentación complementaria en un lactante con lactancia materna exclusiva sin problemas de crecimiento?

- A) 3 meses
- B) 4 meses
- C) 6 meses
- D) 9 meses
- E) 12 meses

PREGUNTA 2

RN de término, alimentado con lactancia materna exclusiva. ¿Qué suplemento debe indicarse desde el primer mes de vida?

- A) Hierro 2 mg/kg/día
- B) Vitamina D 400 UI/día
- C) Flúor 0.25 mg/día
- D) Vitamina K 1 mg IM dosis única al nacer
- E) Calcio 500 mg/día

PREGUNTA 3

Madre pregunta si puede darle miel a su bebé de 8 meses para aliviar la tos. ¿Cuál es la respuesta correcta?

- A) Sí, la miel es segura y tiene propiedades antitusivas comprobadas en lactantes
- B) Solo si es miel orgánica certificada sin aditivos
- C) No, la miel está contraindicada en menores de 12 meses por riesgo de botulismo
- D) Solo en dosis menores de 5 mL no representa riesgo
- E) Sí, si se calienta previamente elimina las esporas

RESUMEN: VACUNAS Y ALIMENTACIÓN EN PEDIATRÍA

tip Coqueluche: la vacuna a la embarazada en el 3er trimestre transfiere anticuerpos al RN, protegiéndolo antes de su primera dosis a los 2 meses (cuando más se mueren).
warning La fiebre leve o resfrío común NO contraindican la vacunación. Solo se difiere si la enfermedad aguda es grave (criterio clínico).
note VIH asintomático / sin inmunosupresión grave NO contraindica la mayoría de las vacunas. Revisar caso a caso.